

Concours



Epreuve Commune 2024

Avec Justification



 [Lien Page Instagram](#)

**PRÉPA
CONCOURS
MSPS**



**OFFRE DE PRÉPARATION AU CONCOURS COMMUN
DE RECRUTEMENT - INSCRIPTION OUVERTE**

1. **La Région de Fès-Meknès est répartie entre les provinces et préfectures suivantes :**
- A) La préfecture de Fès
 - B) La préfecture de Meknès
 - C) La province de Sidi Kacem
 - D) La province de Taounate
2. **Comment appelle-t-on le CHU situé dans la région de Fès-Meknès ?**
- A) CHU Mohammed VI
 - B) CHU Ibn Sina
 - C) CHU Hassan II
 - D) CHU Ibn Rochd
3. **Comment appelle-t-on le Centre hospitalier régional de la région de Fès-Meknès ?**
- A) CHR Mohammed V
 - B) CHR Ibn Baja
 - C) CHR Moulay Youssef
 - D) CHR El Ghassani
4. **Comment appelle-t-on le directeur régional de la santé de la région de Fès-Meknès ?**
- A) Mehdi El Elballoti
 - B) Salima Saasaa
 - C) Allal Amraoui
 - D) Khalid Ait Taleb
5. **Où se situe le siège de la direction régionale de la santé (Fès-Meknès) ?**
- A) Fès
 - B) Meknès
 - C) Taza
 - D) Taounate
6. **Le secteur étatique de santé comprend :**
- A) Les officines
 - B) Le réseau hospitalier public
 - C) Les hôpitaux des soins des ligues et fondations
 - D) Les services de santé des Forces Armées Royales



7. **Parmi les fonctions suivantes, quelles sont celles recommandées par l'OMS pour le renforcement du système de santé ?**
- A) La fonction financement des systèmes de santé
 - B) La fonction personnels de santé
 - C) La fonction prestations des services de santé
 - D) La fonction gouvernance et direction
8. **Les urgences médicales de proximité faisant partie du réseau intégré des soins d'urgences médicales assurent les fonctions d'urgence suivantes :**
- A) Transfert sanitaire simple 24 / 24
 - B) Les gestes de premier secours
 - C) La transfusion
 - D) Le diagnostic de détresse vitale
9. **Les structures suivantes constituent le réseau de soins de santé de base :**
- A) Le dispensaire rural
 - B) Le centre de santé de 1^{er} niveau rural
 - C) Le centre de santé de 2^{ème} niveau urbain
 - D) L'hôpital de proximité
10. **La prévention secondaire sert à :**
- A) Réduire l'incidence d'une maladie
 - B) Réduire la durée d'une maladie
 - C) Réduire les séquelles d'une maladie
 - D) Éviter le développement de la maladie
11. **Pour l'organisation financière du GST, les ressources sont :**
- A) Revenus générés par ses activités
 - B) Revenus des fonds mobiliers et immobiliers
 - C) Dépenses d'investissement
 - D) Dépenses de fonctionnement
12. **Pour l'organisation financière du GST, les dépenses sont :**
- A) Subventions de l'État
 - B) Les dons et legs
 - C) Dépenses d'investissement
 - D) Dépenses de fonctionnement
13. **Le ministère de la Santé est doté dans son organisation de :**
- A) 10 directions



- B) 8 directions
- C) 7 directions
- D) 6 directions

14. Les hôpitaux universitaires sont :

- A) Des hôpitaux de proximité
- B) Des hôpitaux de recours interrégional ou national
- C) Des centres d'enseignement et de recherche
- D) Des hôpitaux de recours régional

15. Une direction régionale de Santé est composée de :

- A) 6 services et 2 unités
- B) 5 services et 3 unités
- C) 4 services et 4 unités
- D) 3 services et 5 unités

16. Les établissements du Croissant-Rouge marocain font partie de :

- A) Secteur public
- B) Secteur privé à but non lucratif
- C) Secteur privé à but lucratif
- D) Du ministère de la Santé

17. Dans le système de l'offre de soins au Maroc, les structures d'appui de l'ESSP sont constituées de :

- A) L'Institut national d'hygiène
- B) Centre de diagnostic et de traitement des maladies respiratoires (CDTMR)
- C) Centre de référence de la planification sanitaire
- D) Centre national antipoison et pharmacovigilance

18. Laquelle des directions suivantes ne fait pas partie du Ministère de la Santé ?

- A) Direction du personnel et contentieux
- B) Direction des médicaments et de pharmacie
- C) Direction de la population
- D) Direction de réglementation et de contentieux

19. Selon l'OMS, la santé est un complet bien-être :

- A) Physique
- B) Physique et social
- C) Physique et mental
- D) Physique, mental et social



20. Lequel des établissements suivants n'est pas médicalisé ?

- A) Dispensaire rural
- B) Centre de santé 1^{er} niveau rural
- C) Centre de santé 1^{er} niveau urbain
- D) Centre de santé 2^{ème} niveau urbain

21. Les services extérieurs du Ministère de la Santé sont représentés par :

- A) Les directions régionales de santé
- B) Les délégations provinciales de santé
- C) Les divisions centrales
- D) Les directions centrales

22. Au Maroc, l'offre de soins est assurée par :

- A) Le secteur public
- B) Le secteur privé
- C) Le secteur public et le secteur privé
- D) Le secteur public, privé et traditionnel

23. La Haute Autorité de la Santé :

- A) Personne morale de droit public jouissant de l'autonomie financière, dénommée dans la présente loi « Autorité ».
- B) Un établissement semi-public doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, ci-après dénommé le « Groupe ».
- C) Elle est basée à Casablanca.
- D) Elle est basée à Rabat.

24. Il sera exécuté et publié au Bulletin officiel, à la suite du présent Dahir, la Loi n° 07-22 portant création de la Haute Autorité de la Santé. Fait en :

- A) 30 novembre 2021
- B) 30 novembre 2022
- C) 30 novembre 2023
- D) 30 novembre 2024

25. Taux de mortalité infantile (pour mille naissances) :

- A) 17,8
- B) 17,9
- C) 18,0
- D) 18,1

26. Indice synthétique de fécondité (ISF) – nombre d'enfants par femme :

- A) 2,37
- B) 2,38
- C) 2,39
- D) 2,40

27. La direction régionale de santé est composée des services suivants :

- A) Le service de la santé publique
- B) Le service de l'offre de soins
- C) Le service des approvisionnements, des bâtiments, des équipements et de la maintenance
- D) Le service des ressources humaines et des contentieux

28. Les hôpitaux peuvent être classés selon :

- A) Le statut juridique ou selon le mode de gestion
- B) La nature de l'offre de soins
- C) Le niveau des prestations offertes (niveau de recours)
- D) Toutes les réponses sont correctes

29. L'offre de soins du ministère de la Santé est organisée en :

- A) Un réseau
- B) Deux réseaux
- C) Trois réseaux
- D) Quatre réseaux

30. Le réseau intégré des soins d'urgences médicales (RISUM) est organisé en trois niveaux qui sont :

- A) Les urgences médicales de proximité
- B) Les urgences pré-hospitalières
- C) Les urgences médico-hospitalières
- D) Les urgences médico-hospitalières complètes

31. Taux brut de natalité (pour mille habitants) :

- A) 16,2
- B) 17,2
- C) 18,2
- D) 19,2

32. Taux brut de mortalité (pour mille habitants) :

- A) 22,9

- B) 1,3
- C) 19,7
- D) 5,1

33. La loi 09-22 est relative à la création de :

- A) HAS : Haute Autorité de Santé
- B) GST : Groupement Sanitaire Territorial
- C) Agence Marocaine des Médicaments et des Produits de Santé
- D) La fonction sanitaire

34. Conformément à l'article 23 de la loi-cadre n° 06-22, la loi 09-22 définit :

- A) Les garanties essentielles accordées au conseil d'administration du GST
- B) Les garanties essentielles accordées aux institutions du ministère de la Santé et de la Protection Sociale
- C) Les garanties essentielles accordées aux ressources humaines des métiers de la santé
- D) La digitalisation du système national de santé

35. Direction et gestion du GST :

- A) Le groupement est dirigé par un Directeur Général et géré par un Conseil d'Administration (CA)
- B) Le groupement est dirigé par un Conseil d'Administration (CA) et géré par un Directeur Général
- C) Le CA se compose d'un président et de membres
- D) Le CA se compose de membres sans obligation d'avoir un président

36. Le Conseil d'Administration (CA) se compose, en plus de son président, des membres suivants :

- A) Le président du conseil régional ou son représentant
- B) Le wali de la région ou son représentant
- C) Le directeur régional du ministère de la Justice ou son représentant
- D) Un représentant de chaque organisme responsable de la gestion de l'AMO



1. **La Région de Fès-Meknès est répartie entre les provinces et préfectures suivantes**

- A) La préfecture de Fès
- B) La préfecture de Meknès
- C) La province de Sidi Kacem
- D) La province de Taounate

LA MONOGRAPHIE DE LA REGION FES-MEKNES

Télécharger la monographie de la région de Fès-Meknès

Située au centre nord du Maroc, la région de Fès-Meknès est née du découpage régional de 2015 à partir des trois anciennes régions : Fès-Boulemane, Meknès-Tafilalet et Taza-Al Hoceima-Taounate. De par son histoire et sa situation géographique au cœur du Royaume, la Région de Fès-Meknès constitue un carrefour stratégique pour les diverses activités économiques et pour l'animation interne et externe des échanges, répartie entre les provinces et préfectures suivantes :

- La préfecture de Fès ;
- La préfecture de Meknès ;
- La province de Moulay Yacoub ;
- La province de Sefrou ;
- La province d'El hajeb ;
- La province de Boulemane
- La province d'Ifrane
- La province de Taza
- La province de Taounate



La région de Fès-Meknès est découpée en 194 communes dont 33 urbaines.

2. **Comment appelle-t-on le CHU situé dans la région de Fès-Meknès ?**

- A) CHU Mohammed VI
- B) CHU Ibn Sina
- C) CHU Hassan II
- D) CHU Ibn Rochd



المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني - فاس
ⵎⵓⵏⵓⵙⵜ ⵉⵎⵓⵙⵜ ⵉⵎⵓⵙⵜ ⵉⵎⵓⵙⵜ ⵉⵎⵓⵙⵜ ⵉⵎⵓⵙⵜ
CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE HASSAN II - FÈS

3. **Comment appelle-t-on le Centre hospitalier régional de la région de Fès-Meknès ?**

- A) CHR Mohammed V
- B) CHR Ibn Baja
- C) CHR Moulay Youssef
- D) CHR El Ghassani



4. **Comment appelle-t-on le directeur régional de la santé de la région de Fès-Meknès ?**

- A) Mehdi El Elballoti
- B) Salima Saasaa
- C) Allal Amraoui
- D) Khalid Ait Taleb





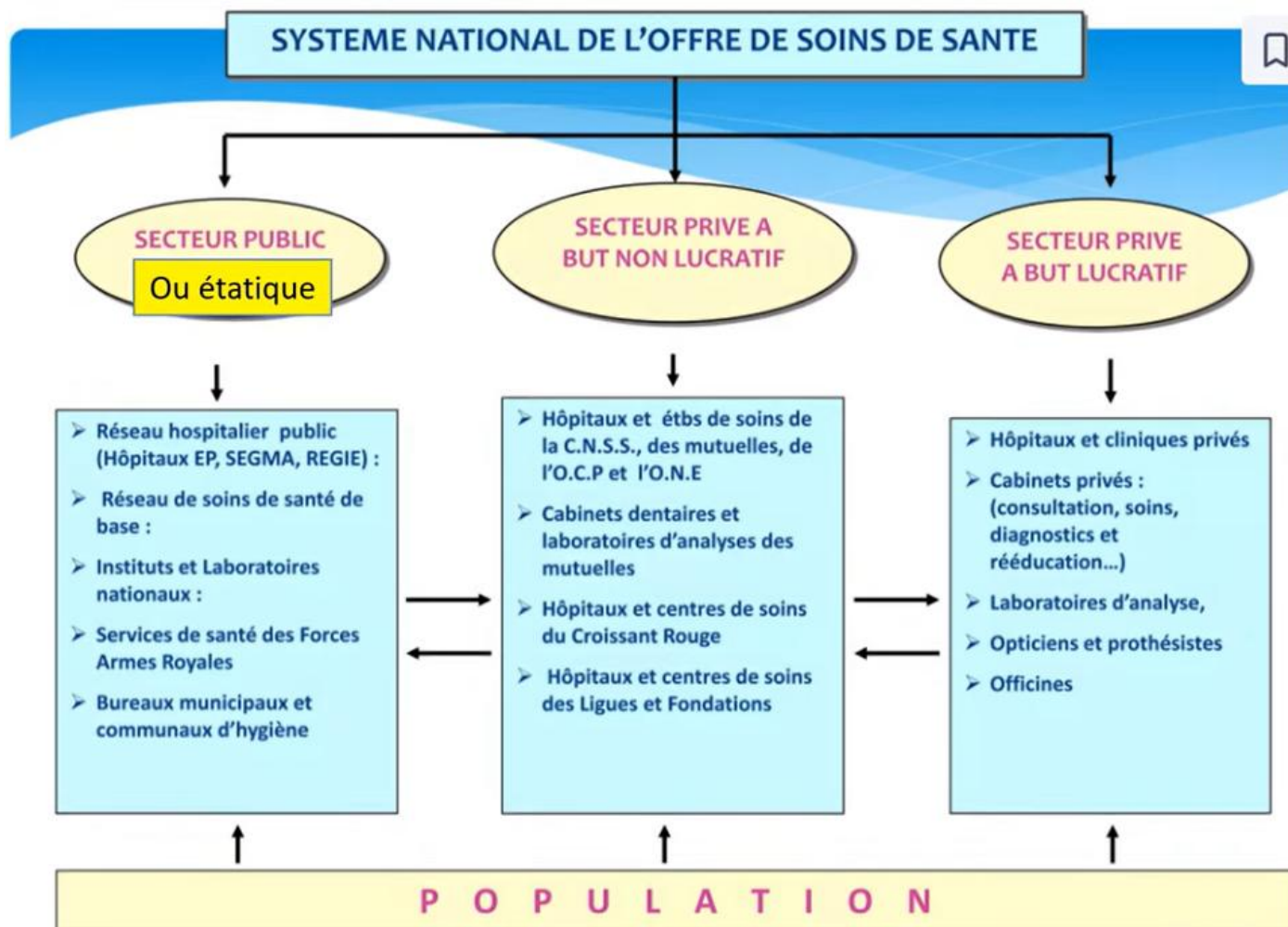
La santé a désormais une nouvelle directrice régionale à Fès-Meknès. Il s'agit de Salima Saâsaâ qui succède à El Mehdi Elballoti, rappelé pour des responsabilités au cabinet du ministre de la Santé et de la Protection Sociale, Khalid Aït Taleb. La nouvelle directrice était jusque là responsable de la santé au niveau de la région de Dakhla-Oued Eddahab, où elle a grimpé tous les échelons durant un parcours de plus de 16 ans. A Fès-Meknès, elle hérite l'offre sanitaire régionale, la plus équilibrée et la plus importante, avec notamment le CHU Hassan II de Fès, leader en matière d'offre de soins et des moyens techniques modernes, ainsi que des ressources humaines ayant les capacités requises pour mettre en

5. **Où se situe le siège de la direction régionale de la santé (Fès-Meknès) ?**

- A) Fès
- B) Meknès
- C) Taza
- D) Taounate

6. **Le secteur étatique de santé comprend :**

- A) Les officines
- B) Le réseau hospitalier public
- C) Les hôpitaux des soins des ligues et fondations
- D) Les services de santé des Forces Armées Royales



7. Parmi les fonctions suivantes, quelles sont celles recommandées par l'OMS pour le renforcement du système de santé ?

- A) La fonction financement des systèmes de santé
- B) La fonction personnels de santé
- C) La fonction prestations des services de santé
- D) La fonction gouvernance et direction

Fonctions du système de santé

- **Prestation de services de santé** : Doit offrir au bon moment et au bon endroit, à ceux qui en ont besoin des prestations de qualité, en évitant de gaspiller les ressources.
- **Personnels de santé** : Doivent répondre aux besoins et agir de façon juste pour atteindre les meilleurs résultats possibles.
- **Médicaments et vaccins** : Doit garantir un accès équitable aux médicaments essentiels, vaccins et à des technologies de qualité pour un coût raisonnable.

Fonctions du système de santé

- **Système d'information** : Doit assurer la production, l'analyse, la diffusion et l'utilisation d'informations fiables sur les déterminants de la santé, le fonctionnement du système de santé et l'état de santé de la population.
- **Financement des systèmes de santé** : L'objectif est d'avoir suffisamment de moyens pour que la population accède aux services nécessaires et soit protégée du risque d'appauvrissement lié au paiement des services de santé.
- **Direction et gouvernance** : Un système de santé suppose l'existence de cadres stratégiques, de réglementations, un encadrement efficace, et une attention particulière à la conception des systèmes et à la transparence.



8. **Les urgences médicales de proximité faisant partie du réseau intégré des soins d'urgences médicales assurent les fonctions d'urgence suivantes :**

- A) Transfert sanitaire simple 24 / 24
- B) Les gestes de premier secours
- C) La transfusion
- D) Le diagnostic de détresse vitale

**Les fonctions de soins d'urgence médicale
annexe n° 2**

• **LES URGENCES MEDICALES DE PROXIMITE (UMP): 7 fonctions de soins d'urgence** sont préconisées à ce niveau (F1 à F7) :

- F1 : Permanence 24/24 (*Garde ou Astreinte*) ;
- F2 : Diagnostic clinique des détresses vitales ;
- F3 : Gestes et manœuvres de premier secours : *massage cardiaque, aspiration/libération des voies aériennes supérieures, Oxygène, pose d'une perfusion, pose d'un garrot compressif, sonde vésicale, administration parentérale de médicaments vitaux (antalgique, sédatif, antispasmodique, antibiotique, etc.), suture de plaie simple, mise en condition de l'urgent pour son transfert à un niveau supérieur ;*
- F4 : Contention provisoire et immobilisation de fractures par attelles (*minerves, attelles*)
- F5 : Surveillance du patient (*salle d'observation*) ;
- F6 : Examen biologique de base : 3 paramètres (*Automate*) : NFS, Glycémie, urée ; 3 paramètres (*Bandelettes réactifs*) albuminurie, glucosurie, acétonurie ;
- F7 : Transfert sanitaire simple 24/24.

• **LES URGENCES MEDICO-HOSPITALIERES DE BASE (UMHB)**

En plus des fonctions UMP précitées, on trouve 5 autres fonctions à ce niveau (F8 à F12).

- F8 : Gestes de ressuscitation et de réanimation (F3 + Déchoquage cardio-vasculaire, sédation, intubation/ventilation, Sonde gastrique, monitoring)
- F9 : Examen complémentaire de Base : (F6 + Echographie, ionogramme, bactériologie, immunologie) ;
- F10 : Transfusion ;
- F11 : Hospitalisation ;
- F12 : Intervention chirurgicale (Bloc opératoire).

• **LES URGENCES MEDICO-HOSPITALIERES COMPLETES (UMHC)**

En plus des fonctions des UMHB, on trouve les 4 autres fonctions suivantes à ce niveau :

- F13 : Fonction de réanimation hospitalière polyvalente (prise en charge complète des défaillances viscérales aiguës mettant directement en jeu le pronostic vital) ;
- F14 : Examens complémentaires complets : (F11 + TDM/IRM, explorations fonctionnelles ou invasives, virologie, etc.) ;
- F15 : Transfert SMUR en plus de F9 ;
- F16 : Régulation des appels médicaux.

• **Les Urgences Médico-Hospitalières spécialisées (UMHS)**

- Urgences obstétricales, Urgences psychiatriques,
- Prise en charge des brûlés, oxvénotherapie hyperbare...

9. **Les structures suivantes constituent le réseau de soins de santé de base :**

- A) Le dispensaire rural
- B) Le centre de santé de 1^{er} niveau rural
- C) Le centre de santé de 2^{ème} niveau urbain
- D) L'hôpital de proximité

Réseau des établissements de soins de santé primaires (art. 21 à 26)

* ESSP en milieu rural

- * Centre de santé rural de premier niveau: CSR1 (ex CSC)
- * Centre de santé rural de 2^{ème} niveau : CSR2 (ex CSCA)
- * +/-Dispensaire rural au besoin (DR)

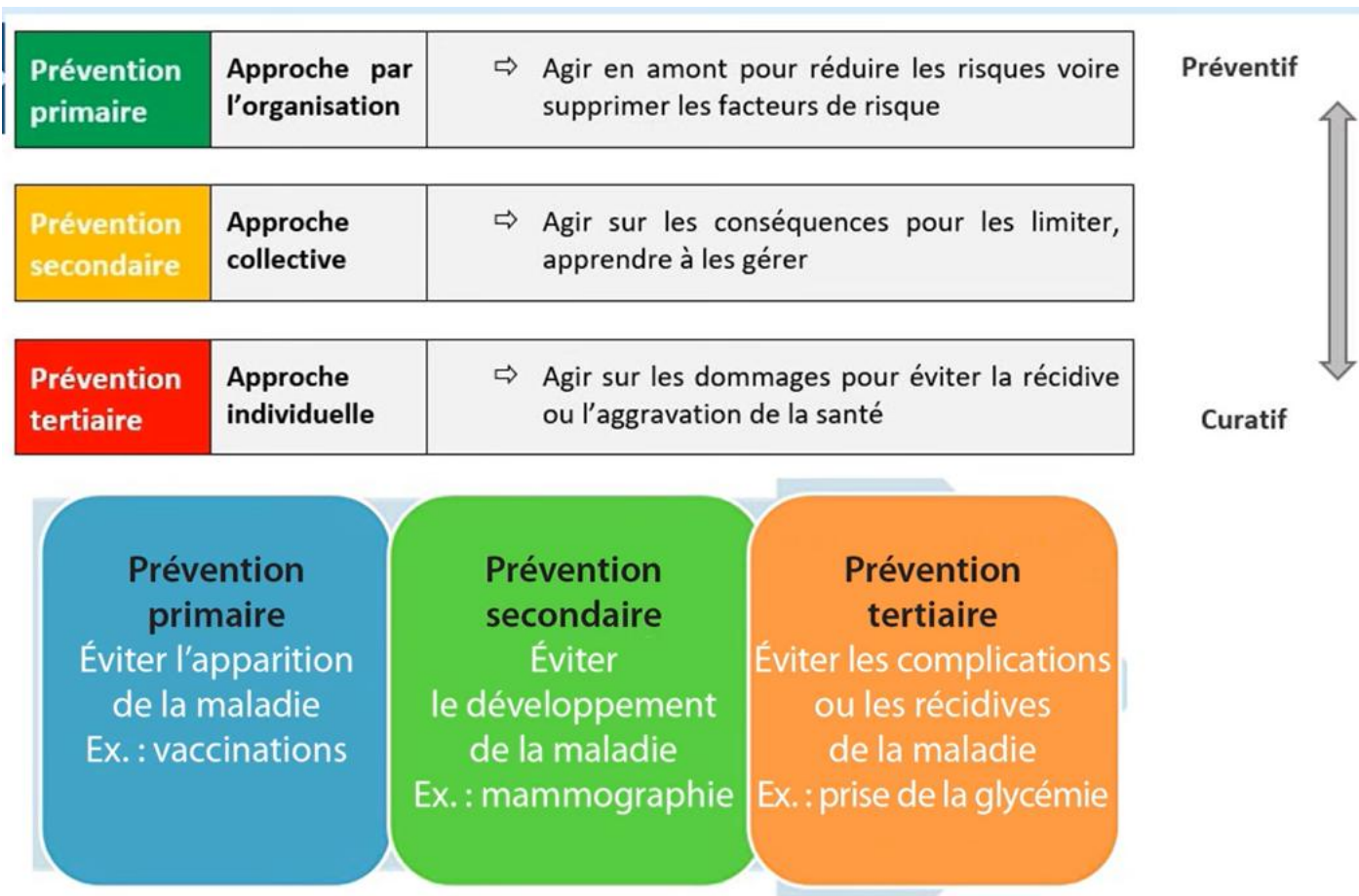
* ESSP en milieu urbain

- * Centre de santé urbain de premier niveau : CSU1 (ex CSU)
- * Centre de santé urbain de 2^{ème} niveau: CSU2 (ex CSUA)

10. La prévention secondaire sert à :

- A) Réduire l'incidence d'une maladie
- B) Réduire la durée d'une maladie
- C) Réduire les séquelles d'une maladie
- D) Éviter le développement de la maladie





11. **Pour l'organisation financière du GST, les ressources/Recettes sont :**

- A) Revenus générés par ses activités
- B) Revenus des fonds mobiliers et immobiliers
- C) Dépenses d'investissement
- D) Dépenses de fonctionnement

L'organisation financière du GST

Le budget du groupement (Article 13)

Rubrique ressources

- Revenus générés par ses activités
- Revenus des fonds mobiliers et immobiliers
- Subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toute autorité soumise à la loi publique ou privée
- Les dons et legs
- Toute autre ressource selon les textes réglementaires et juridiques en vigueur.

Rubrique dépenses

- Dépenses d'investissement
- Dépenses de fonctionnement
- Remboursement des avances et des emprunts
- Toute autre dépense en relation avec les missions du groupement

Le recouvrement des dettes du groupement se fait selon les textes juridiques en vigueur en relation avec le recouvrement des dettes publiques (Article 14)

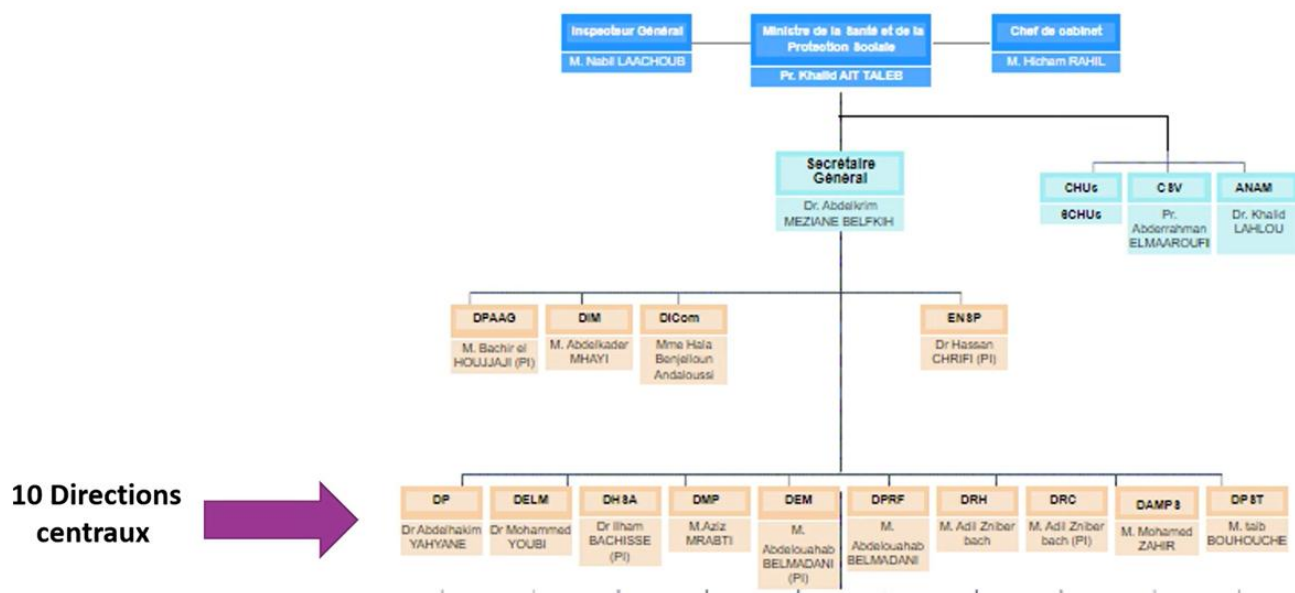
12. Pour l'organisation financière du GST, les dépenses sont :

- A) Subventions de l'État
- B) Les dons et legs
- C) Dépenses d'investissement
- D) Dépenses de fonctionnement

13. Le ministère de la Santé est doté dans son organisation de :

- A) 10 directions
- B) 8 directions
- C) 7 directions
- D) 6 directions





14. Les hôpitaux universitaires sont :

- A) Des hôpitaux de proximité
- B) Des hôpitaux de recours interrégional ou national
- C) Des centres d'enseignement et de recherche
- D) Des hôpitaux de recours régional

2. Hôpitaux universitaires de recours interrégional ou de référence nationale

- * constitué d'un ensemble d'établissements comprenant une gamme complète de services hautement spécialisés .
- * Spécialités de pointe en plus
- * Le CHU est un centre d'enseignement et de recherche,
- * Encadrement du REH
- * son aire d'influence s'étend sur la région qu'il dessert et pour quelques disciplines à l'ensemble du pays

15. Une direction régionale de Santé est composée de :

- A) 6 services et 2 unités
- B) 5 services et 3 unités
- C) 4 services et 4 unités
- D) 3 services et 5 unités

ORGANIGRAMME :

Chaque direction régionale de la santé est composée de **6 services et 2 unités** suivants:

► Les services :

1. Service de la santé publique
2. Service de l'offre de soins
3. Observatoire régional de santé
4. Service des ressources financières, de la logistique et du partenariat
5. Service des ressources humaines et contentieux
6. Service des équipements et de la maintenance.

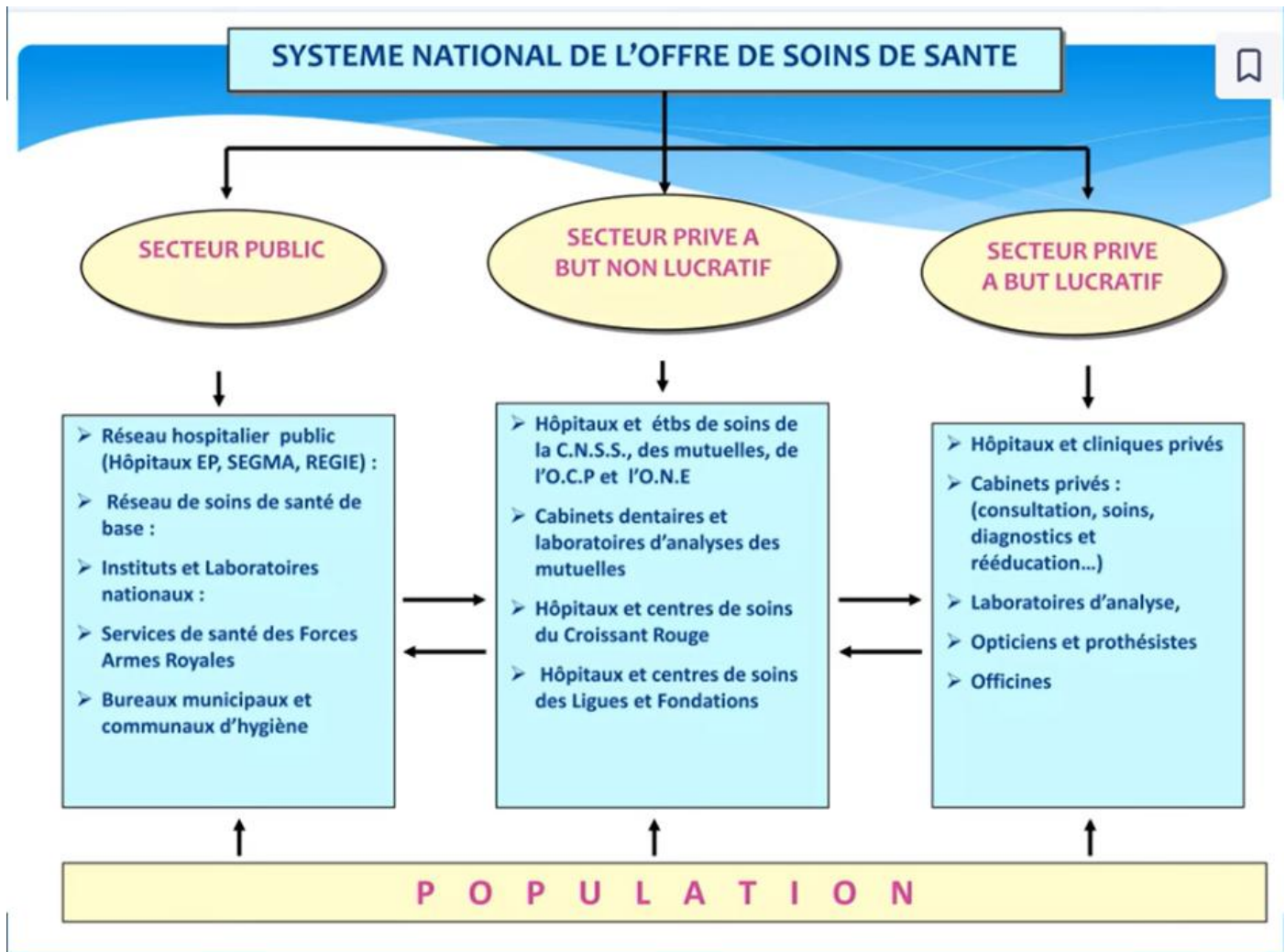
► Les unités :

1. Une unité régionale d'approvisionnement et de pharmacie
2. Une unité régionale de communication et information,



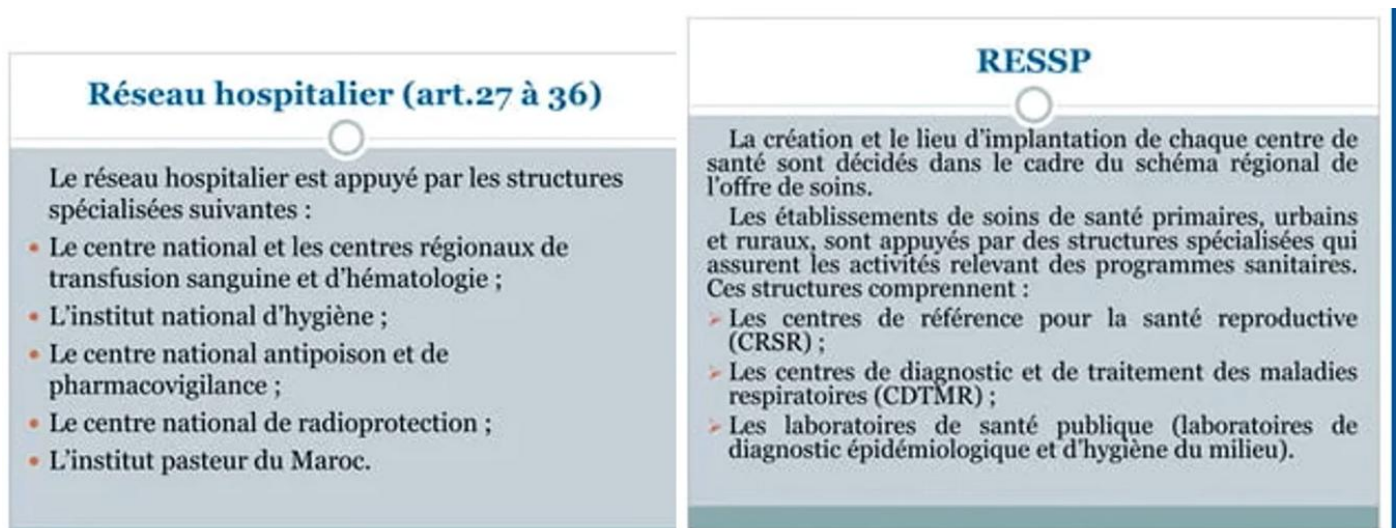
16. Les établissements du Croissant-Rouge marocain font partie de :

- A) Secteur public
- B) Secteur privé à but non lucratif
- C) Secteur privé à but lucratif
- D) Du ministère de la Santé



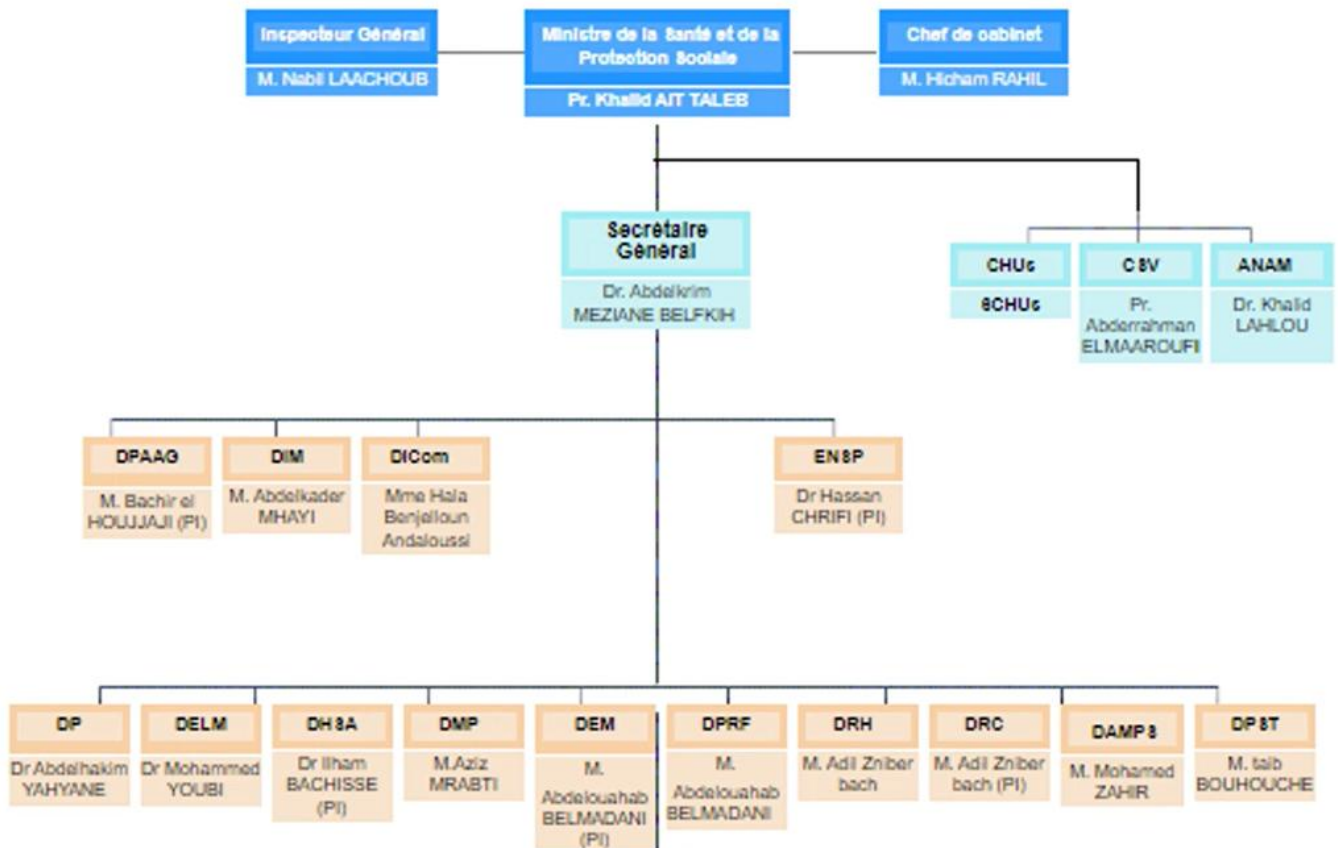
17. Dans le système de l'offre de soins au Maroc, les structures d'appui de l'ESSP sont constituées de :

- A) L'Institut national d'hygiène
- B) Centre de diagnostic et de traitement des maladies respiratoires (CDTMR)**
- C) Centre de référence de la planification sanitaire
- D) Centre national antipoison et pharmacovigilance



18. **Laquelle des directions suivantes ne fait pas partie du Ministère de la Santé ?**

- A) Direction du personnel et contentieux
- B) Direction des médicaments et de pharmacie
- C) Direction de la population
- D) Direction de réglementation et de contentieux



19. **Selon l'OMS, la santé est un complet bien-être :**

- A) Physique
- B) Physique et social
- C) Physique et mental
- D) Physique, mental et social



L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) définit la santé comme « un état de complet bien-être physique, mental et social, [qui] ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité »¹. La santé est ainsi prise en compte dans sa globalité.

20. Lequel des établissements suivants n'est pas médicalisé ?

- A) Dispensaire rural
- B) Centre de santé 1^{er} niveau rural
- C) Centre de santé 1^{er} niveau urbain
- D) Centre de santé 2^{ème} niveau urbain

Le dispensaire rural (DR) : c'est le plus petit établissement de soins de santé de base. Il constitue l'unité opérationnelle de premier recours, **non médicalisée**, la plus décentralisée du système sanitaire devant délivrer les soins de santé essentiels (promotion, prévention et soins).

Son implantation est prévue, en plus du centre de santé communal implanté au chef lieu, dans les communes qui desservent une population importante et dont les localités sont étalées sur de grandes superficies

21. Les services extérieurs du Ministère de la Santé sont représentés par :

- A) Les directions régionales de santé
- B) Les délégations provinciales de santé
- C) Les divisions centrales
- D) Les directions centrales

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - Les services déconcentrés du ministère de la santé sont constitués des directions régionales de la santé et des délégations préfectorales et provinciales, instituées respectivement dans les ressorts territoriaux des wilayas de régions, et des préfectures, préfectures d'arrondissements ou provinces, telles qu'elles sont déterminées par le dahir n° 1-59-351 du 1er jourada II 1379 (2 décembre 1959) relatif à la division administrative du Royaume.

22. Au Maroc, l'offre de soins est assurée par :

- A) Le secteur public
- B) Le secteur privé
- C) Le secteur public et le secteur privé
- D) Le secteur public, privé et traditionnel



LE DISPOSITIF DE L'OFFRE DE SOINS AU MAROC :

1. ORGANISATION EN SECTEURS :

Deux grands types de secteurs :

☉ Secteurs formels :

- Secteur Public;
- Secteur Privé à but non lucratif;
- Secteur Privé à but lucratif;

☉ Secteur informel : (médecine traditionnelle)

23. La Haute Autorité de la Santé :

- A) Personne morale de droit public jouissant de l'autonomie financière, dénommée dans la présente loi « Autorité ».
- B) Un établissement **semi-public** doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, ci-après dénommé le « Groupe ».



C) Elle est basée à Casablanca.

D) Elle est basée à Rabat.

الباب الأول التسمية والغرض المادة الأولى

يحدث، تحت اسم «الهيئة العليا للصحة»، شخص اعتباري من
أشخاص القانون العام يتمتع بالاستقلال المالي، ويكون مقرها في
الرباط ويشار إليها في هذا القانون بـ «الهيئة».

24. **Il sera exécuté et publié au Bulletin officiel, à la suite du présent Dahir, la Loi n° 07-22 portant création de la Haute Autorité de la Santé. Fait en :**

A) 30 novembre 2021

B) 30 novembre 2022

C) 30 novembre 2023

D) 30 novembre 2024



ظهير شريف رقم 1.23.84 صادر في 16 من جمادى الأولى 1445
(30 نوفمبر 2023) بتنفيذ القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث
الهيئة العليا للصحة.

الحمد لله وحده.

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماء الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه.

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية. عقب ظهيرنا الشريف هذا.
القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة. كما وافق
عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 16 من جمادى الأولى 1445 (30 نوفمبر 2023).

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عزيز أخنوش.

25. Taux de mortalité infantile (pour mille naissances) :

A) 17,8

B) 17,9

C) 18,0

D) 18,1

Taux de Mortalité Infantile¹

(Pour mille naissances)

National	18,0
Urbain 14,9	Rural 21,6



26. **Indice synthétique de fécondité (ISF) – nombre d'enfants par femme :**

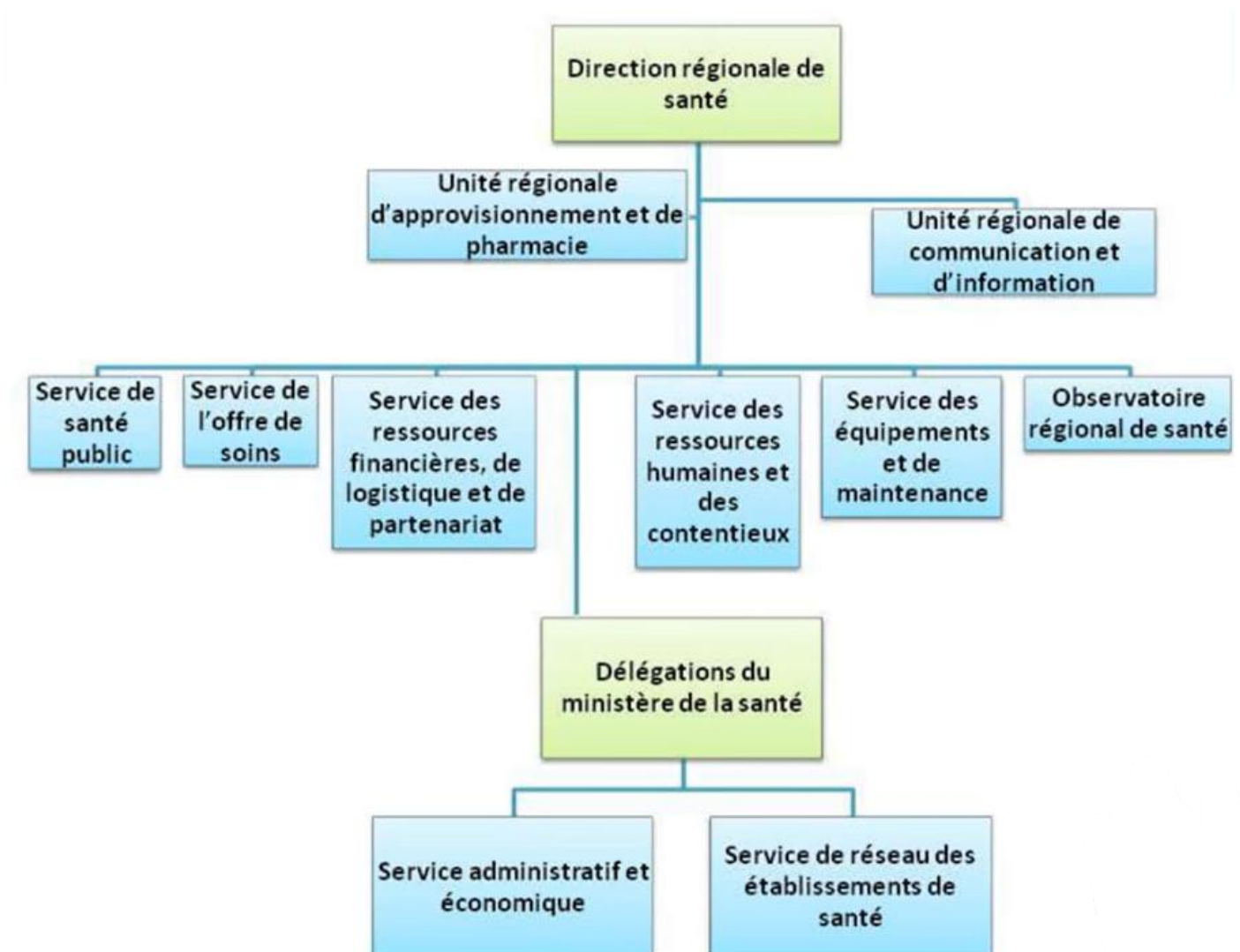
- A) 2,37
- B) 2,38
- C) 2,39
- D) 2,40

Indice Synthétique de Fécondité (ISF)¹
(Nombre d'enfants par femme)

National	2,38
Urbain 2,12	Rural 2,8

27. **La direction régionale de santé est composée des services suivants :**

- A) Le service de la santé publique
- B) Le service de l'offre de soins
- C) Le service des approvisionnements, des bâtiments, des équipements et de la maintenance
- D) Le service des ressources humaines et des contentieux



28. Les hôpitaux peuvent être classés selon :

- A) Le statut juridique ou selon le mode de gestion
- B) La nature de l'offre de soins
- C) Le niveau des prestations offertes (niveau de recours)
- D) Toutes les réponses sont correctes

RH TYPOLOGIE DES HÔPITAUX



Les hôpitaux sont classés selon leurs:

- o Nature de l'offre de soins
- o Mode de gestion financière (Statut)
- o Niveau de recours (implantation)

29. L'offre de soins du ministère de la Santé est organisée en :

- A) Un réseau
- B) Deux réseaux
- C) Trois réseaux
- D) Quatre réseaux

* «L'offre publique de soins en mode fixe est composée des quatre réseaux d'établissements de santé suivants :

1. Le réseau des établissements de soins de santé primaires (**RESSP**);
2. Le réseau hospitalier (**RH**);
3. Le réseau intégré des soins d'urgence médicale (**RISUM**);
4. Le réseau des établissements médico-sociaux (**REMS**).



30. **Le réseau intégré des soins d'urgences médicales (RISUM) est organisé en trois niveaux qui sont :**

- A) Les urgences médicales de proximité
- B) Les urgences pré-hospitalières
- C) Les urgences médico-hospitalières
- D) Les urgences médico-hospitalières complètes

◉ Le réseau intégré des soins d'urgence médicale (**RISUM**) accomplit sa mission selon les trois modes suivants (Article 38, décret)

1. **les Urgences Médicales de Proximité (U.M.P)**, assurées par les centres de santé de deuxième niveau implantés dans les chefs-lieux de cercles ;
2. **les Urgences Pré-hospitalières (UPH)**, assurées par
 1. les moyens de transport de secours de base,
 2. les services médicaux d'urgence et de réanimation (SMUR)
 3. et les services médicaux hélicoptérés (HELISMUR);
3. **les Urgences médico-hospitalières (UMH)**, qui comprennent
 1. les urgences médico-hospitalières de base assurées par les centres hospitaliers préfectoraux ou provinciaux,
 2. les urgences médico-hospitalières complètes assurées par les centres hospitaliers régionaux
 3. et les urgences médico-hospitalières spécialisées assurées par les centres hospitaliers interrégionaux.

31. **Taux brut de natalité (pour mille habitants) :2022**

- A) 16,2
- B) 17,2
- C) 18,2
- D) 19,2

Taux Brut de Natalité ²
(Pour mille habitants)

National		15,7
Urbain	15,2	Rural 16,7



32. **Taux brut de mortalité (pour mille habitants) :2022**

- A) 22,9
- B) 1,3
- C) 19,7
- D) 5,1

Taux Brut de Mortalité²
(Pour mille habitants)

National	5,2
Urbain 4,4	Rural 6,5

33. **La loi 09-22 est relative à la création de :**

- A) HAS : Haute Autorité de Santé
- B) GST : Groupement Sanitaire Territorial
- C) Agence Marocaine des Médicaments et des Produits de Santé
- D) La fonction sanitaire

قانون رقم 09.22
يتعلق بالوظيفة الصحية

34. **Conformément à l'article 23 de la loi-cadre n° 06-22, la loi 09-22 définit :**

- A) Les garanties essentielles accordées au conseil d'administration du GST
- B) Les garanties essentielles accordées aux institutions du ministère de la Santé et de la Protection Sociale
- C) Les garanties essentielles accordées aux ressources humaines des métiers de la santé
- D) La digitalisation du système national de santé



الباب الأول

أحكام عامة

المادة الأولى

تطبيقاً لأحكام المادة 23 من القانون - الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، يحدد هذا القانون الضمانات الأساسية الممنوحة لمهنيي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية.

35. Direction et gestion du GST :

- A) Le groupement est dirigé par un Directeur Général **et géré** par un Conseil d'Administration (CA)
- B) Le groupement est dirigé par un Conseil d'Administration (CA) et géré par un Directeur Général
- C) Le CA se compose d'un président et de membres
- D) Le CA se compose de membres sans obligation d'avoir un président

Direction d'un GST

- ▶ Le Groupement est dirigé par un Conseil d'Administration (CA) et géré par un Directeur Général.
- ▶ Le CA se compose, en plus de son président, **des membres suivants** :

36. Le Conseil d'Administration (CA) se compose, en plus de son président, des membres suivants :

- A) Le président du conseil régional ou son représentant
- B) Le wali de la région ou son représentant
- C) Le directeur régional du ministère de la Justice ou son représentant
- D) Un représentant de chaque organisme responsable de la gestion de l'AMO

LE GROUPEMENT EST DIRIGÉ PAR UN CONSEIL D'ADMINISTRATION (CA) ET GÉRÉ PAR UN DIRECTEUR GÉNÉRAL.

